

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師	病院薬剤師
☐ 膵酵素製剤の服用タイミング・量と脂肪便・体重の確認 ☐ オピオイドのレスキュー回数・便秘・眠気の確認 ☐ 電話フォローで発熱・寒気・黄疽・下痢を確認 ☐ 他院の睡眠薬・市販薬を含めた併用薬の確認 ☐ 疼痛・症状をトレーシングレポートで病院へ共有	☐ 全身状態・gBRCA・UGT1A1とレジメンの整合性の監査 ☐ FOLFIRINOXの減量(modified)とG-CSF予防の設定 ☐ 疼痛・胆管炎など症状悪化時の院内連携(緩和ケア・消化器) ☐ 携帯型ポンプの準備と外来化学療法室での説明 ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載
病院と共有する情報 レジメン・胆道ステント 検査値 疼痛の強さ・レスキュー 食事量・体重・黄疽	

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

レジメン・薬剤	構成・投与スケジュール	周期	薬局での確認ポイント
modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン+イリノテカン+レボホリナート→5-FU 46時間持続静注(急速静注は省略)	2週毎	携帯型ポンプ、G-CSF予防、UGT1A1、下痢・しびれ
GEM+nab-PTX	ゲムシタピン+ナブパクリタキセル 1・8・15日目	4週毎	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、発熱
ゲムシタピン単剤	1・8・15日目	4週毎	投与当日～翌日の発熱・倦怠感、骨髄抑制、間質性肺炎
S-1単剤	4週服用・2週休薬(術後補助は6か月)	6週毎	腎機能に応じた用量、下痢・口内炎、他のフッ化ピリミジンは併用禁忌
nal-IRI+5-FU/LV	イリノテカン リポソーム製剤+レボホリナート+5-FU 46時間	2週毎	遅発性下痢、好中球減少、UGT1A1
オラパリブ	300mg 1日2回 連日内服(維持療法)	連日	貧血(定期的な血液検査)、悪心、CYP3A阻害薬・誘導薬

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 併用注意	S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定を処方医と確認
注意 添付文書 併用注意	エルロチニブ(ゲムシタピン併用) 胃内pH上昇・CYP1A2誘導	処方薬 市販薬 生活習慣 PPI・H2ブロッカー・喫煙	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬と喫煙状況を確認
注意 添付文書 併用注意	オラパリブ CYP3A阻害・誘導	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系・リファンピシン	副作用↑・効果↓	他院の抗菌薬・抗真菌薬・抗結核薬を確認
注意 添付文書 併用注意	オピオイド 中枢抑制の重複	処方薬 睡眠薬・抗不安薬(他院処方)	過鎮静・呼吸抑制・転倒	他院の睡眠薬・抗不安薬を確認
確認 服薬指導上の注意	オピオイド 便秘対策の不足	市販薬 下剤の自己中断・市販の刺激性下剤	便秘の遷延・腸閉塞	下剤の処方と市販薬の使用状況を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前	投与後～5日	投与後1～2週	次回来局時
「消化酵素のお薬は食事のすぐ後に飲むと、脂っこい便や体重減少を防ぎやすくなります」 確認: お薬手帳で全身状態・gBRCA・UGT1A1、胆道ステントの有無 △皮膚や白目が黄色い(黄疽)時は至急連絡	「下痢止めや吐き気止めは指示どおりに。ゲムシタピン後の発熱は一時的なことが多いですが、続く時は連絡を」 確認: 電話フォローで下痢・水分量、携帯型ポンプの抜針、G-CSFの予定 △水様便が止まらない・水分がとれない時は至急連絡	「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」 確認: 電話フォローでnadir期の発熱・寒気、食事量 △発熱+寒気は胆管炎・FNを疑い至急受診	「痛み止めは効いていますか。便秘や眠気、手足のしびれで困っていることはありませんか」 確認: 疼痛の強さ・レスキュー回数、便秘、体重、しびれ △痛みの急な増強・便が出ない状態が続く時は連絡